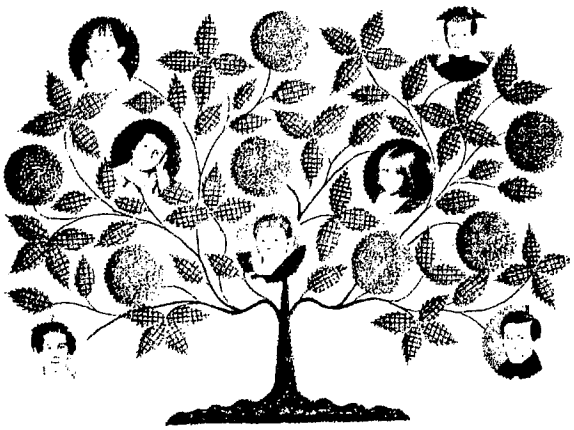
J. Manzano F. Palacio Espasa
N. Zilkha



Scenari della genitorialità

La consultazione genitori - bambino

Raffaello Cortina Editore

I

SCENARI NARCISISTICI DELLA GENITORIALITÀ

In tutta la sua opera, Sigmund Freud ha studiato le relazioni genitori-figli concentrandosi unicamente su questi ultimi. Tutta la teoria freudiana dello sviluppo psichico può essere considerata, di conseguenza, come un'esplorazione del modo con cui il bambino esperimenta questa relazione e di quali ne siano le conseguenze per lui. Dunque, Freud ha utilizzato quasi esclusivamente un approccio unidirezionale e non ha praticamente mai considerato il modo con cui i genitori vivono questa relazione né le ripercussioni che essa può avere sul loro funzionamento psichico. Nella sua teoria (Freud, 1905) ha mostrato come il bambino, in un primo tempo, trovi nella madre un oggetto per i propri impulsi libidici, sotto una forma "anaclitica", per appoggio sulle "prime esperienze di soddisfacimento" dei suoi bisogni vitali (di conservazione); il bambino ama la madre che si prende cura di lui. L'evoluzione che ne consegue è ben conosciuta: attraverso le tappe di maturazione e di organizzazione psicosessuale, l'investimento libidico sull'oggetto si allarga al genitore di sesso opposto e trasforma l'altro genitore in oggetto di rivalità e di timore; si tratta del complesso di Edipo e delle sue vicissitudini, che andranno, più tardi, a influenzare i rapporti con i partner della relazione amorosa adulta.

Nondimeno, quando Freud introduce il concetto di narcisismo, nel 1914, descrive un'altra forma di relazione possibile, una *scelta* di oggetto libidico che definisce appunto "narcisistico". In questo caso, non sono né la "donna nutrice" né "l'uomo protettivo" a costituire il prototipo degli interessi libidici, bensì il proprio Sé che si ama nella madre e in tutta la serie delle persone sostitutive che partono da essa e con le quali si stabilisce questa "relazione narcisistica".

È nella patologia adulta che Freud aveva scoperto la "relazione nar-

cisistica": in apparenza molto paradossale nei suoi termini. Egli ha descritto delle persone che non scelgono gli oggetti d'amore sul modello della propria madre, bensì su quello della propria persona, di una rappresentazione di se stessi. Ciascuna di queste persone ama così nell'altro: "quel che egli stesso è, quel che egli stesso era, quel che egli stesso vorrebbe essere, la persona che fu una parte del proprio sé" (Freud, 1914, p. 460).

Per Freud, queste due vie che portano alla scelta dell'oggetto sono aperte a qualsiasi essere umano, che potrà così stabilire le proprie relazioni secondo una modalità oggettuale (per appoggio) e secondo una modalità narcisistica. L'una o l'altra può avere la preferenza ed essere predominante.

Arrivato a questo punto della sua descrizione della *scelta oggettuale narcisistica*, Freud si discosta eccezionalmente dal bambino per considerare la relazione narcisistica dal punto di vista dei genitori. Per lui, esiste in questi ultimi "una coazione ad attribuire al bambino ogni sorta di perfezioni (*His Majesty the Baby*) [...] e a dimenticare e coprire ogni sua manchevolezza", "a rinnovare per lui la rivendicazione di privilegi a cui da tempo hanno rinunciato"; di conseguenza, "egli deve davvero ridiventare il centro e il nocciolo del creato [...] che i genitori si sentivano un tempo". L'amore dei genitori per i loro figli, secondo Freud, non sarebbe altro che il loro narcisismo che rinasce, il loro amore per se stessi. A posteriori, preciserà questo concetto in termini di ideale dell'Io: i genitori collocheranno sul bambino il loro proprio ideale dell'Io (ciò che amerebbero essere), con il quale il bambino si identificherà, facendone il proprio ideale che, a sua volta, giunto in età adulta, proietterà sul proprio figlio; Freud si spinge fino al punto di ipotizzare che, dati gli aspetti "culturali" di questo ideale dell'Io proiettato, esso potrebbe spiegare il meccanismo dell'eredità culturale intergenerazionale.

Nelle sue osservazioni sulla psicopatologia adulta che abbiamo citato poco sopra, Freud aveva ugualmente osservato "con una particolare chiarezza" alcune forme di relazioni amorose adulte in cui il soggetto colloca nell'oggetto d'amore (all'occorrenza persone più giovani) i propri aspetti infantili, mentre egli stesso gioca il ruolo della madre ideale della prima infanzia, che ha creduto o desiderato avere, che soddisfaceva tutti i suoi bisogni e desideri e con la quale ora si identifica. In questa "messa in scena inconscia" – di cui oggi conosciamo la frequenza clinica –, il soggetto ama se stesso nel proprio partner e per di più in maniera assoluta, nella forma di quella madre ideale che egli stesso incarna.

In mancanza di esperienza clinica diretta della relazione genitori-figli, Freud non ha mai fatto esplicitamente il confronto fra queste relazioni amorose narcisistiche adulte e ciò che descriveva come una relazione narcisistica dei genitori con i loro figli, limitandosi, come abbiamo visto, a considerare il suo carattere generale. Ora, la nostra prassi clinica di consultazioni terapeutiche genitori-neonati/bambini, ci ha permesso di constatare che alcune configurazioni relazionali simili a quelle descritte a proposito delle relazioni amorose narcisistiche adulte sono presenti in proporzioni e in forme variabili in tutte le relazioni genitori-figli. Queste "messe in scena" inconsce sono variabili e le ritroviamo, ad esempio, nel caso ben conosciuto della madre che proietta sul neonato l'immagine del proprio padre deceduto di cui non ha elaborato il lutto, identificandosi con una figlia che vive con il padre all'interno di una relazione "fusionale" apparentemente oggettuale, oppure nella situazione in cui il padre vede nel figlio il bambino ideale e onnipotente che avrebbe voluto essere, identificandosi, a sua volta, con il padre ugualmente ideale che avrebbe voluto avere.

Siamo stati quindi indotti a formulare il concetto che abbiamo chiamato "scenari narcisistici della genitorialità" e abbiamo potuto differenziarne i principali tipi e forme. Gli scenari sono costituiti da quattro elementi fondamentali:

– una proiezione dei genitori sul figlio;
– un'identificazione complementare del genitore (contro-identificazione);
– uno scopo specifico;
– una dinamica relazionale agita.

La *proiezione* dei genitori sul figlio costituisce più esattamente un'identificazione proiettiva. Si tratta, in effetti, di una rappresentazione di sé (*self*) del genitore che viene proiettata e che, di conseguenza, è investita di libido narcisistica; questa rappresentazione di sé è proiettata sia direttamente in quanto tale – come nell'esempio sopracitato: la rappresentazione del figlio ideale che il padre avrebbe voluto essere – sia tramite l'immagine interna di un oggetto, come nell'altro esempio: l'immagine del padre morto della madre. In quest'ultimo caso, quest'immagine – l'oggetto interno del genitore – è portatrice di una rappresentazione del *self* che era stata innanzitutto proiettata su di lui; in altri termini, è avvenuta un'identificazione con questo oggetto. In realtà, anche se la proiezione sul figlio corrisponde a un'immagine oggettuale, essa comporta necessariamente una rappresentazione di sé e, di conseguenza, è di natura narcisistica. Possiamo dire, parafrasando Freud, che l'ombra dei genitori è caduta sul figlio, sia direttamente, sia attraverso l'ombra dei loro oggetti interni.

L'*identificazione complementare* dei genitori, che abbiamo chiamato contro-identificazione, si effettua con un'altra rappresentazione interna; nei nostri esempi, l'immagine della figlia che aveva ancora un padre vivo, o il padre ideale che avremmo voluto avere. In questo modo, lo scenario è sempre conforme a una relazione tra "Sé" e "Sé".

Lo *scopo* della messa in scena comporta quindi, in tutti i casi, la realizzazione di una soddisfazione di natura narcisistica. Ma altri scopi possono ugualmente emergere e aggiungersi: di natura difensiva – come un diniego della perdita – o tali da permettere soddisfazioni libidiche oggettuali, come il soddisfacimento mascherato di pulsioni edipiche rimosse.

L'*interazione agita* tra i protagonisti è il risultato di queste proiezioni e identificazioni. Il fatto che lo scenario si svolga proprio nella realtà è di importanza fondamentale, perché ciò permette di conferirgli un'esistenza che oltrepassa l'immaginario puro e di convertirlo così in un sintomo a cui si legano soddisfacimenti sostitutivi mascherati.

Abbiamo potuto differenziare due modalità dinamiche differenti in queste interazioni; l'una consiste nel "fissare" una scena, facendo di tutto per convincersi che essa esiste veramente con un carattere immutabile: ad esempio, che il figlio e il padre della situazione sopracitata rimangano sempre ideali; l'altra consiste, al contrario, nel "ripetere" un passato giudicato inaccettabile, "correggendolo" nel verso desiderato, come ad esempio quando proiettiamo sul figlio l'immagine del figlio triste e abbandonato che abbiamo creduto di essere e, identificandoci in genitori che non abbandonano, ricostruiamo retroattivamente la nostra storia personale, diventando il figlio che non ha mai vissuto separazioni.

Così, i fantasmi e i ruoli immaginari inconsci determinano non solamente la rappresentazione di sé (*self*) dei genitori ma anche le loro condotte verso i figli, nel senso generale del temine: atteggiamenti e comportamenti verbali e non verbali, espressioni d'affetto, mancanze, ecc. Non è sempre possibile cogliere il dettaglio di questi meccanismi in una determinata situazione, ma la nostra esperienza terapeutica ci porta a sottolineare che a volte è molto facile mettere in evidenza un comportamento relativamente semplice di un genitore che accompagna le sue proiezioni e identificazioni e che ha una ripercussione diretta sul figlio; per esempio, in casi di disturbo del sonno, troviamo frequentemente una madre che proietta sul figlio l'immagine interna di una persona del proprio passato, malata o morta, e questo la induce ad andare più volte per notte a svegliare il bambino per verificare che sia sempre vivo. Altre turbe, come il vomito e l'anoressia, possono scaturire da una

opposizione del figlio a un comportamento intrusivo chiaramente osservabile nella madre. Nella maggior parte dei casi, la madre seleziona e rafforza certe forme di espressione del figlio che, in questo modo, tendono a far parte del sistema specifico di comunicazione madre-figlio o genitori-figlio.

Il figlio reagirà, dunque, a queste pressioni fantasmatiche espresse nel comportamento comunicativo dei genitori, in funzione delle proprie motivazioni, e soprattutto del bisogno di attaccamento e di "holding" suscitato dalle pulsioni e dalle difese; si identificherà, totalmente o parzialmente, nella rappresentazione proiettata su di lui ma può anche riproiettare e rigettare il ruolo che i genitori gli attribuiscono: questo può disturbare il suo sviluppo e provocare l'insorgenza di alcuni sintomi.

È sempre necessario, quando impieghiamo il concetto polisemico di narcisismo, precisare quale accezione di esso stiamo utilizzando. Per quanto ci riguarda, noi lo usiamo nel senso generale introdotto da Freud di "amore di sé", investimento libidico sulla propria personalità o sulla rappresentazione di sé (*self*), differente dall'amore oggettuale, per l'altro differenziato da sé, "il correlato libidico dell'egoismo". Senza entrare nella discussione circa l'esistenza o meno di una fase di narcisismo primario, in questo lavoro utilizziamo sempre il concetto di narcisismo come narcisismo secondario, descritto nella teoria di Melanie Klein (1946) e Otto Kernberg (1980) come l'esistenza di una rappresentazione oggettuale dell'altro diventato il proprio *self* tramite i fantasmi d'identificazione introiettiva e proiettiva che possono eliminare totalmente o parzialmente i limiti tra Sé e oggetto. Questa concezione permette di spiegare la coesistenza di una relazione narcisistica – amore di sé nell'altro – e di una vera relazione oggettuale: amore dell'altro come differente da sé. La descrizione degli scenari narcisistici della genitorialità illustra, a nostro parere, questa formulazione della relazione narcisistica dei genitori con i figli (in quanto rappresentazione di loro stessi), coesistente con una relazione oggettuale in cui il figlio è amato in quanto essere differenziato. Per noi, come abbiamo segnalato poco sopra, queste due forme di relazione fanno parte, in proporzioni variabili, di tutte le relazioni genitori-figli; tuttavia, nei casi "patologici" che ci consultano per problemi precoci dello sviluppo, constatiamo generalmente una predominanza della relazione narcisistica con il figlio, mentre in situazioni meno conflittuali la relazione narcisistica – sempre esistente – è progressivamente superata da una relazione oggettuale, in cui il figlio è riconosciuto e amato in maniera predominante in quanto essere differente.

Gli scenari narcisistici della genitorialità possono dunque essere superati e integrarsi nello sviluppo armonico delle relazioni genitori-figli; ma possono anche essere patologici nella misura in cui interferiscono in questo sviluppo ed entrano in conflitto con la realtà, e particolarmente con la realtà dell'esistenza di un figlio in crescita, che non corrisponde alla proiezione che è stata depositata su di lui.

In quest'ultimo caso, la dinamica dell'interazione ha esiti diversi. Un equilibrio tra le diverse forze è possibile: il figlio si adatta alla pressione proiettiva e gioca il ruolo che gli viene assegnato senza presentare disturbi apparenti dell'adattamento; logicamente, queste situazioni non richiedono aiuto per problemi nella relazione o nello sviluppo, ma possiamo immaginare che questi figli manifesteranno difficoltà psicologiche più tardive. Viceversa, le situazioni per le quali si chiede una consultazione sono quelle in cui l'equilibrio è messo in difficoltà: schematicamente, il figlio, crescendo, non gioca più il ruolo che gli è stato assegnato e manifesta il proprio bisogno di essere riconosciuto in quanto persona e non più come "l'ombra dei genitori o dei loro oggetti interni" e questo comporta uno scompenso da parte dei genitori; oppure la sua acquiescenza alle proiezioni dei genitori gli pone dei problemi relativi allo sviluppo e all'adattamento al mondo esterno; oppure, ancora, la situazione si presenta come una combinazione di questi due esiti.

Nella pratica clinica di queste consultazioni, si possono evidenziare questi scenari narcisistici a partire da fonti di informazione differenti. Si tratta, in primo luogo, di considerare che almeno una delle due parti dell'interazione – la madre o il padre – pur interagendo a livello preverbale con il neonato, dispone di un linguaggio verbale; essa è capace di esprimere il proprio pensiero conscio e di lasciare trasparire i propri contenuti inconsci. Lo stesso dicasi con un figlio in età più avanzata e con un adolescente. In secondo luogo, la madre stabilisce una relazione emotiva non solamente con il figlio ma anche con il terapeuta. I discorsi della madre – le sue associazioni – possono permettere di inferire i suoi fantasmi inconsci, soprattutto quelli che concernono e accompagnano la sua attività reale con il figlio, ma anche quelli che sostengono la relazione con il terapeuta in quello che abbiamo chiamato pretransfert; quest'ultimo può informarci riguardo la natura del legame madre-figlio grazie al parallelismo esistente tra questo legame e quello con il terapeuta.

Nello stesso modo, l'insieme delle contro-reazioni (sentimenti e pensieri) che la proiezione degli oggetti interni della madre e/o di altre parti del suo Sé provocano nel terapeuta, costituisce per noi una delle principali fonti di evidenza, grazie alla possibilità di insight e di auto-

osservazione che esse forniscono. Queste fonti di informazione sono completate dai dati obbiettivi rilevati con l'osservazione del comportamento interattivo tra madre e figlio (Cramer, Stern, 1988; Lebovici, 1983) e anche tramite la valutazione clinica (stato mentale) della madre e del figlio, che il clinico ben preparato può effettuare abbastanza rapidamente durante il corso della consultazione.

Tutti questi dati, collocati nel contesto delle conoscenze teoriche e delle esperienze pratiche di psicopatologia individuale e relazionale di cui dispone il terapeuta, possono permettergli di effettuare una scelta "mirata" della dinamica relazionale su cui baserà la propria comprensione e l'intervento interpretativo.

Per facilitare questa esplorazione, abbiamo messo a punto una "griglia" concettuale della situazione, che permetta un'elaborazione più rapida delle informazioni. Questa griglia, che svilupperemo e illustreremo clinicamente più avanti, comprende i seguenti elementi:

– proiezione predominante dei genitori;
– contro-identificazione dei genitori;
– scopo della proiezione;
– reazione del figlio alla proiezione;
– comprensione dei sintomi. Impressione diagnostica relativa al figlio e ai genitori;
– fattori che hanno provocato lo squilibrio che ha portato alla consultazione;
– pretransfert dei genitori;
– pretransfert del figlio;
– contro-reazioni del terapeuta;
– interventi del terapeuta;
– evoluzione della situazione.

La nostra concezione degli "scenari narcisistici della genitorialità" ha alcuni punti di contatto con altri approcci pubblicati nella letteratura scientifica. Come abbiamo segnalato, Freud (1922) concede una posizione predominante ai meccanismi di identificazione nella formazione dello psichismo del figlio; ha inoltre aperto la via agli studi sulla trasmissione generazionale e sulla filiazione (la "transgenerazionalità") (Lebovici, 1983; Kaës, 1993; Golse, 1966), su ciò che il figlio riceve in "eredità" dai genitori. In un'altra prospettiva, questi stessi temi sono stati trattati dai sostenitori della teoria dell'attaccamento (Bowlby, 1988; Main, 1990; Fonagy et al., 1993; Mazet, 1996). Anche in un contesto incentrato prevalentemente sulla cura psicanalitica, fin dallo studio di Mijolla *Les visiteurs du moi* (1981) e di Abraham e Torok (1978), molti autori hanno

cercato di precisare le condizioni metapsicologiche della trasmissione intergenerazionale a partire dal materiale retrospettivo dell'analisi di adulti (Baranes, 1991; Enriquez, 1988; Guyotat, 1980). A questo proposito, possiamo citare, in particolare, la concezione di Faimberg (1988) di *télescopage générationnel* ("collisione generazionale").

Più vicine al nostro lavoro, troviamo le terapie psicanalitiche pionieristiche di Selma Fraiberg (1975), riguardo ai *fantasmi nelle camere dei bambini* e centrate sul suo concetto di ripetizione, per le madri, di loro esperienze infantili negative nella relazione con i figli, tramite meccanismi di identificazione inconsci con l'aggressore; si può dire altrettanto per i recenti punti di vista di Fonagy (1996). Ma è l'insieme degli studi di Bertrand Cramer sulla psicoterapia breve (1974, 1993), a partire dalla sua nozione di "interazione fantasmatica", che ha molto contribuito a sviluppare le nostre conoscenze in questo campo. Recentemente, sebbene all'interno di una concettualizzazione differente, Raphael-Leff (1995) ha pubblicato il resoconto di un suo studio clinico con genitori e figli, in cui giunge a constatazioni vicine alle nostre per quanto riguarda gli "spostamenti narcisistici" tra i genitori e il figlio che presenta disturbi della relazione; proprio come noi, insiste sull'importanza dei "fantasmi narcisistici" che possono sostituire la realtà e compromettere l'interazione genitori-figli.

II

LA CONSULTAZIONE TERAPEUTICA: GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA TECNICA

INTRODUZIONE

Nella letteratura scientifica, il termine di consultazione terapeutica è stato introdotto da Winnicott (1971) per descrivere un metodo d'intervento psicoterapeutico con il bambino tramite incontri sporadici e non stabiliti in maniera sistematica come nel "setting" convenzionale. Benché tenga conto, nei suoi esempi clinici, del contributo dei genitori alla problematica del figlio, Winnicott interviene raramente nei loro confronti; concentra essenzialmente la propria azione sul figlio, con il quale utilizza la tecnica dello "*squiggle*", lasciando all'interpretazione una posizione secondaria e privilegiando il rapporto di fiducia. Da parte sua, la Mahler (1968) aveva utilizzato le psicoterapie madre-figlio nei casi di psicosi simbiotiche, nei quali i fantasmi materni giocavano un ruolo importante nella conservazione dell'illusione simbiotica del figlio.

Ma è soprattutto la Fraiberg (1975, 1980) ad aver introdotto nei paesi anglosassoni il lavoro psicoterapeutico sistematico, breve o a lungo termine, con le madri e i loro bambini, evidenziando in quale modo i fantasmi materni operino un'intrusione nel funzionamento di questi ultimi (*ghosts in the nursery*, "fantasmi nella camera del bambino").

Nei paesi francofoni, Lebovici (1986) è stato uno dei pionieri della consultazione terapeutica, attraverso la quale, mediante l'adozione di comportamenti ludici con il bambino in presenza della madre, ha potuto sbloccare alcuni circoli viziosi sintomatici. Durante tutto il suo ricchissimo lavoro, Lebovici ha approfondito questa consultazione terapeutica genitori-figli (1983, 1986) e ha sviluppato alcuni concetti divenuti ormai classici, come quelli di "trasmissione generazionale", "*enaction*", ecc. L'intervento diretto sul bambino e le sue ripercussioni tera-

peutiche sul complesso familiare – particolarmente sulle ripetizioni transgenerazionali dei genitori – caratterizzano l'originalità di Lebovici in questo campo. Cramer (1974) è anch'egli un pioniere; con il suo studio sugli interventi terapeutici brevi e con il concetto fondamentale della "mutualità psichica" tra genitori e figli attraverso i processi di proiezione, introiezione e identificazione. I suoi studi hanno permesso di valutare i risultati molto positivi di questo tipo di terapia (1982), così come la natura del processo psicoterapeutico che caratterizza questo approccio (1993), di cui ha sottolineato il ruolo cruciale nel periodo particolarmente favorevole del *post-partum* (1974). Sul piano tecnico, ha messo in evidenza l'importanza, per il terapeuta, di individuare un "focus terapeutico" e di scoprire "le sequenze interattive sintomatiche" tra il bambino e la madre, che consentano di elaborarlo (Cramer, Palacio Espasa, 1993). Abbiamo noi stessi applicato il termine di consultazione terapeutica al nostro lavoro psicoterapeutico breve con le madri e i bambini (Manzano, Palacio Espasa, 1981, 1989, 1994; Palacio Espasa, Manzano, 1982). Questa nozione più ampia di consultazione terapeutica, in cui l'intervento psicoterapeutico viene effettuato, secondo i casi, sia con ciascuno dei genitori sia con il figlio, è oggi utilizzato in Francia da clinici che ne hanno sviluppato gli aspetti più ricchi e originali, in particolare Berger (1986, 1987), Golse (1990), Houzel (1995), Sanchez-Cardenas (1994).

A partire dalla nostra esperienza di terapie brevi di bambini molto piccoli e delle loro madri, nonché dagli studi di B. Cramer, abbiamo ampliato il nostro approccio psicoterapeutico breve alla totalità delle situazioni di consultazione con genitori e figli di tutte le età, compresi gli adolescenti. In effetti, abbiamo potuto constatare che i principi teorici e tecnici applicati alla relazione precoce madre-figlio erano utilizzabili con profitto in differenti tappe della vita. Come per i bambini più piccoli, la relazione tra genitori e figli più grandi – e ancor più con figli adolescenti – può essere oggetto del nostro intervento breve (consultazione terapeutica), seguendo gli stessi criteri d'indicazione e di controindicazione. La differenza essenziale consiste nel tenere conto del fatto che l'interpretazione sarà indirizzata non solamente ai genitori ma ugualmente e simultaneamente al bambino e all'adolescente. Le proiezioni dei genitori sul bambino e sull'adolescente (e viceversa) sono anche di natura un po' differente, particolarmente per ciò che concerne il conflitto edipico che si inserisce nello scenario narcisistico.

L'interpretazione rivolta ai genitori di fronte al figlio permette a quest'ultimo di prendere coscienza del sovraccarico conflittuale di cui soffre a causa della proiezione genitoriale. Agendo in questo modo, lo alleggeriamo di un peso, tanto che le interruzioni di terapia dovute a un'iniziativa del bambino sono molto rare (mentre non lo sono nelle psicoterapie infantili individuali). Contemporaneamente, l'interpretazione rivolta al figlio in presenza dei genitori permette a entrambi di capire il conflitto che generano nell'altro e che si autoalimenta in un circolo vizioso. Ciò dà al genitore la possibilità di rendersi conto della propria problematica narcisistica e di elaborare il lutto degli oggetti del passato. Quanto al figlio, questi può, a sua volta, proseguire nel lavoro di elaborazione della propria conflittualità senza che il sovraccarico delle proiezioni genitoriali lo obblighi ad adottare soluzioni regressive. In questi casi, la possibilità di continuare un lavoro a lungo termine rimane aperta, sia con il figlio, sia con il genitore.

A parere nostro, questa tecnica si adatta in modo particolare alle condizioni "ecologiche" delle consultazioni in psichiatria del bambino e dell'adolescente e offre uno strumento terapeutico che risponde alla domanda della maggior parte di queste consultazioni, per le quali è spesso utopico pensare ad approcci psicoterapeutici di più lunga durata; peraltro, nel momento in cui un intervento breve è controindicato o quando una psicoterapia individuale classica risulta prioritaria, l'approccio breve della relazione genitori-figlio si rivela in generale compatibile e può facilitare questo intervento. Nella pratica, queste consultazioni terapeutiche si rivolgono più frequentemente alla relazione madre-bambino o madre-adolescente, ma anche ai padri; in seguito, ci riferiremo indistintamente alla madre e al padre anche se, per comodità espositiva, menzioniamo di più la madre.

Il nostro modello di comprensione è basato sulla nostra concezione degli scenari narcisistici della genitorialità, che abbiamo sviluppato nel capitolo precedente. Presuppone dunque l'esistenza di ciò che Cramer (1982) chiama "l'interazione fantasmatica madre-figlio" ed è basato sulla concezione psicoanalitica dello sviluppo e sul ruolo dei fantasmi genitoriali nella costituzione dello psichismo del figlio, così come sulle reazioni dei genitori ai fantasmi di quest'ultimo.

Riteniamo che la definizione di fantasma inconscio formulata da Melanie Klein sia la più compatibile con la nostra esperienza: "Un'attività mentale che accompagna e che sostiene fin dalla nascita ogni processo psichico" (S. Isaacs, 1948). Il fantasma inconscio è la rappresentazione psichica dell'istinto e trae la propria origine dall'interpretazione primitiva delle sensazioni corporee di base (piacere e dispiacere), che sono immediatamente attribuite a un oggetto che ne sarebbe responsabile. Que-

ste sensazioni sono dunque rappresentate mentalmente come una relazione d'oggetto, e l'oggetto è, di conseguenza, costruito in primo luogo a partire da queste sensazioni. Il fantasma non è solamente la rappresentazione mentale delle pulsioni istintuali, ma è anche la rappresentazione dei meccanismi di difesa contro queste pulsioni.

Presupporre l'esistenza di un'attività fantasmatica fin dalla nascita implica l'assunzione dell'esistenza di un Io immediatamente organizzato con una relazione oggettuale e, di conseguenza, senza una fase di narcisismo primario (anoggettuale). Esiste dunque, a nostro giudizio, fin dalla nascita, una relazione reciprocamente investita pulsionalmente tra la madre e il figlio. La "simbiosi" o confusione di identità tra i due partner della coppia madre-figlio è, in quest'ottica, intesa come il risultato dei fantasmi difensivi di identificazione proiettiva e introiettiva; questi fantasmi, che fanno parte di uno sviluppo normale, sono il più delle volte attivati contro le angosce di separazione e di perdita d'oggetto (fusione secondaria difensiva) (Rosenfeld, 1965).

INTERAZIONE "OGGETTIVA" E INTERAZIONE "FANTASMATICA"

Una discussione che non può essere evitata è quella dei rapporti tra ciò che Stern (1988) ha definito "realtà oggettiva" e "realtà soggettiva" nell'interazione madre-figlio.

Secondo noi, a questo proposito si pongono tre questioni: in primo luogo, quella della metodologia, del raffronto epistemologico tra osservazione "oggettiva" puramente "behaviorista" e altre forme di conoscenza. Come vedremo più avanti, le fonti di informazione relative alla conoscenza dell'interazione fantasmatica possono essere definite a partire dai seguenti elementi: il discorso della madre (o del padre) così come quello del figlio più grande, che permette delle inferenze sui suoi fantasmi inconsci; alcuni comportamenti della madre e del figlio che possono parimenti permettere delle inferenze; la relazione emotiva (pretransfert) che la madre stabilisce con il terapeuta e la controreazione di quest'ultimo; l'osservazione del comportamento della madre e del figlio nelle loro interazioni, la valutazione del funzionamento psichico (stato mentale) della madre e del bambino o dell'adolescente.

La seconda questione è quella del meccanismo tramite il quale i fantasmi di una persona (per esempio la madre) possono agire sull'altra (per esempio il figlio). Per noi, è evidente che questa influenza non può

esercitarsi se non tramite il comportamento nel senso più generale del termine (verbale, preverbale, atteggiamenti, espressioni d'affetto, mancanze, ecc.); questi comportamenti della madre agiscono come rinforzo e selezione dei comportamenti del figlio sulla base dei bisogni relazionali, pulsionali e difensivi di costui. È ben inteso che non conosciamo sempre il dettaglio di questi meccanismi per una data situazione, ma, come vedremo, non ci mancano le esperienze che ci permettono di continuare in questa direzione. Per scrupolo di chiarezza, sottolineiamo fin d'ora che quando pensiamo che l'intervento terapeutico debba tentare di modificare il fantasma inconscio della madre, perseguiamo la modificazione "comportamentale" che ne deriverà nella relazione.

La vera questione, per noi, è quella del ruolo che viene riconosciuto, nello sviluppo del figlio e dei suoi disturbi, all'esperienza reale esterna e all'interpretazione (o alla creazione) di questa esperienza attraverso il fantasma inconscio. Si possono distinguere due tesi estreme. In maniera schematica, l'una postula che tutto il mondo psichico del figlio, e particolarmente le sue rappresentazioni mentali, derivino esclusivamente da memorie di esperienze reali nella relazione madre-figlio. Per l'altra, è essenzialmente il fantasma inconscio che costruisce la rappresentazione della realtà esterna. Si riconosceranno, in questo dibattito, le tracce delle teorie freudiane che si sono succedute a proposito della seduzione reale e della seduzione fantasmatica nell'origine delle nevrosi. Osserveremo egualmente che ritroviamo qui la vecchia contrapposizione fra l'apporto, nello sviluppo del bambino, di ciò che è innato e di ciò che è acquisito, così come l'opposizione delle teorie psicologiche behavioriste pure e delle teorie costruttiviste (Piaget, Inhelder, 1986).

Per rimanere nei limiti del nostro argomento, pensiamo che nella comprensione della relazione madre (padre) – figlio e delle sue turbe, questo dibattito è tutt'altro che puramente teorico. Dalla risposta che diamo a questa questione dipenderà direttamente il modello eziopatologico, e soprattutto il metodo di intervento terapeutico.

Per ciò che ci concerne, sottoscriviamo la concezione cosiddetta "interazionista", classica in psicoanalisi, secondo la quale gli oggetti esterni (e le loro rappresentazioni interne) sono costruiti simultaneamente, da una parte, tramite la proiezione degli oggetti interni, derivati in parte dai fantasmi inconsci, e dall'altra, dall'esperienza precedente e attuale con questi oggetti esterni. Ciò vuol dire che se accordiamo importanza alla storia reale del figlio, accordiamo un'importanza almeno uguale alla sua storia fantasmatica. Quest'ultima è costruita sulla base delle "convinzioni" relative a ciò a cui si crede di essere pervenuti. Co-

sì, ad esempio, se il soggetto "pensa inconsciamente" di aver "incorporato" l'oggetto esterno, o certe sue qualità, ciò costituisce un'esperienza che va a determinare non solamente la condotta ma anche la rappresentazione del Sé (*self*) e che va a influenzare l'insieme dell'Io, dell'organizzazione e dello sviluppo psichico. Non possiamo dunque, per quanto ci riguarda, fare a meno del fantasma.

Pragmaticamente, nella situazione terapeutica, insistiamo maggiormente sui fantasmi della madre o del padre, non perché pensiamo che siano i soli fattori in causa, ma proprio perché, allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono quelli sui quali possiamo avere più presa.

IL "LUTTO EVOLUTIVO" E L'EMERGERE DELLA GENITORIALITÀ

Abbiamo considerato che lo sfondo sul quale appaiono le turbe della relazione madre-figlio è costituito dall'insieme dei processi psicologici che hanno luogo normalmente nelle madri al momento della nascita del figlio e dell'emergere della genitorialità.

Pensiamo che questi processi costituiscano una "crisi" nel senso definito da Bibring e collaboratori (1961), Erikson (1950) e Caplan (1964). L'elemento centrale di questa crisi implica ciò che abbiamo chiamato *lutto evolutivo*. In effetti, pensiamo che questi eventi della vita implichino sempre la riattivazione del vissuto della perdita di oggetti primitivi, che si tratti dei propri genitori o di altre persone emotivamente significative. Nella misura in cui, nel passato, questo processo di lutto non è stato elaborato, ne ritroveremo alcune manifestazioni dirette e indirette nella relazione con il figlio, sotto forma di scenari narcisistici.

Inoltre, le consultazioni terapeutiche ci hanno insegnato che l'emergere della genitorialità provocato dall'arrivo del figlio induce sia la madre che il padre, nelle loro funzioni genitoriali, a una reidentificazione forzata con l'immagine dei propri genitori.

Questa reidentificazione riattiva inevitabilmente i conflitti con le immagini sessuali dei genitori, investite in modo ambivalente e cariche di rimproveri, addormentate (rimosse) durante la latenza e l'adolescenza.

Come abbiamo segnalato poco sopra, nella nostra esperienza, i padri reagiscono in maniera simmetrica alle madri e proiettano sul figlio i loro oggetti anaclitici primitivi e i loro oggetti edipici conflittuali (utilizziamo il termine anaclitico nel senso che gli ha attribuito Spitz nel 1968, descrivendo la "depressione anaclitica": ossia l'oggetto la cui presenza è vissuta come vitale). Il ruolo del padre, nelle relazioni con il figlio piccolo, è molto simile a quello della madre e presenta sostanzialmente le stesse configurazioni dinamiche. Per il bambino, il padre e la madre giocano indistintamente il "ruolo di terzo"; perciò, i sentimenti di esclusione dalla coppia, le ansie e i relativi conflitti sono sperimentati da ciascuno dei membri della triade. Per di più, come abbiamo visto, il padre – come la madre – può proiettare differenti aspetti del proprio sé (*self*) e del proprio mondo interno.

La ripercussione degli atteggiamenti comportamentali della madre è favorita dall'estrema sensibilità, dalla ricettività "biologica" predeterminata del figlio a ogni messaggio proveniente da lei, in particolare alle manifestazioni d'affetto (Darwin, 1872) e specialmente ai segnali di angoscia (Emde, Soïce, 1983).

IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA

Mai come nelle relazioni madre-lattante il concetto di identificazione proiettiva si rivela uno strumento preciso ed efficace per rendere conto dei fenomeni osservati nella clinica. Ma accade lo stesso anche nelle situazioni con figli più grandi e adolescenti.

Come si sa, il concetto di identificazione proiettiva amplia e approfondisce la nozione freudiana di proiezione, e implica sempre che ciò che è proiettato rappresenta una parte considerata come Sé (*Self*, ivi compresi gli oggetti interni). Nel caso della madre, ciò significa che ella considererà il figlio come una parte di se stessa o dei propri oggetti interni in misura dipendente dall'intensità e dalla natura della proiezione. In effetti, l'identificazione proiettiva della madre è un fantasma normale, che gioca un ruolo importante nello sviluppo e nella comunicazione, ma può diventare patologica per ragioni essenzialmente difensive, particolarmente contro le angosce di separazione e di perdita dell'oggetto.

Nella situazione terapeutica con la madre (o il padre) e il figlio, è di estrema importanza valutare – oltre all'intensità – la natura della proiezione dei genitori; da questa spesso dipenderanno, in gran parte, la nostra comprensione della relazione e la forma del nostro intervento. Per intensità della proiezione intendiamo l'insieme delle caratteristiche che ce la fanno considerare come "patologica", ossia (Hinshelwood, 1987):
– il grado di aggressività e di violenza che l'intrusione veicola nel fantasma della madre, così come il grado di scissione;

– la qualità del controllo onnipotente e della fusione con l'oggetto che ne risulta;
– la quantità di "Io" che la madre perde nella proiezione;
– lo scopo specifico di impedire la comunicazione e la presa di coscienza, in contrasto con l'identificazione proiettiva normale, al servizio dell'empatia.

Per quanto concerne la natura della proiezione, se riprendiamo schematicamente ciò che, in generale, si considera potenzialmente proiettabile, dobbiamo chiederci se si tratta di "pensieri" (Freud, 1920), di pulsioni e derivati pulsionali di oggetti interni (Abraham, 1924), del Super-io o di parti del Super-io (M. Klein, 1945), o di altre parti del *self* (rappresentazione di sé). (Queste distinzioni, anche se le differenze possono sembrare talvolta un po' artificiose, si rivelano, come vedremo, estremamente utili al momento di formulare le nostre interpretazioni.) In pratica, pensiamo, come Melanie Klein nei suoi ultimi studi su questo argomento (1946), che la proiezione su un oggetto esterno (il figlio) di parti di sé è quasi sempre "la proiezione di un oggetto interno che contiene queste parti di sé proiettate in lui". Di fatto, potremmo identificare prima di tutto questo oggetto interno proiettato sul figlio e, in un secondo tempo, le altri parti del *self* della madre che vi sono depositate.

L'identificazione proiettiva non è a senso unico, anche il figlio la utilizza normalmente. La madre gioca un ruolo in qualità di recettore – contenitore – dell'identificazione proiettiva del lattante e del figlio piccolo (Bion, 1959, 1965). Questa capacità che, in maniera meno precisa e specifica, secondo noi, si chiama anche funzione di para-eccitamento, è considerata un fattore indispensabile per lo sviluppo del figlio ed è il prototipo della comunicazione. Nella consultazione terapeutica madre-figlio, è possibile valutare i segnali indicatori di questa capacità della madre di tollerare e accettare la proiezione del figlio e le caratteristiche normali e patologiche di quest'ultimo.

PRETRANSFERT

Le circostanze in cui ha luogo la consultazione madre-figlio e la situazione di crisi in cui si trova la madre, con la regressione e il riassetto pulsionale che implica la maternità (Bibring et al., 1961), facilitano una relazione di natura transferale con il terapeuta. Come abbiamo segnalato, ciò vale anche per i padri; la nascita di un figlio implica sempre, per i

genitori, la perdita dello *status* di figlio e, di conseguenza, un sentimento di perdita delle proprie immagini genitoriali. Ne consegue che essi sono molto desiderosi di immagini genitoriali. Più tardi, al momento della consultazione con figli cresciuti o adolescenti, ritroviamo immancabilmente una crisi simile nei genitori, scatenata dallo stesso squilibrio che motiva la richiesta di aiuto.

Il terapeuta, in tutto ciò che fa, è immediatamente investito. La natura di questo investimento determina la possibilità dell'intervento terapeutico. Si tratta di un investimento intimamente legato a quello della madre verso il figlio e ci informa sulla sua relazione con le proprie immagini genitoriali. I casi in cui la madre stabilisce un pretransfert positivo costituiscono una indicazione di terapia breve; inversamente, quelli in cui la madre stabilisce un pretransfert negativo costituiscono una controindicazione. Tra questi due poli, vi è tutta una gamma di casi intermedi.

In termini di identificazione proiettiva, pensiamo che questa reazione pretransferale abbia sempre, al proprio interno, la proiezione sul terapeuta di oggetti interni della madre, come anche di altri aspetti del suo Sé.

Queste proiezioni transferali sono le stesse che la madre compie sul figlio, o sono in rapporto diretto con esse. Più precisamente, possiamo dire che, nella maggioranza dei casi, l'immagine genitoriale (l'oggetto interno) che la madre proietta sul figlio è simile a quella che proietta sul terapeuta e, per conseguenza, stabilirà una relazione emotiva – positiva, negativa o ambivalente – della stessa natura; ciò vale per ogni altro tipo di proiezione. Nel momento in cui il terapeuta scopre in se stesso le caratteristiche di questa proiezione, può capire più profondamente questo elemento specifico della relazione madre-figlio.

Nella nostra ipotesi di indicazioni favorevoli, un esempio tipico è quello in cui l'immagine proiettata ha le caratteristiche di un oggetto perduto della madre, il più delle volte rappresentazioni del proprio padre o della propria madre. Nei casi più frequenti si tratta della madre, e ciò ci informa sul legame con questa rappresentazione interna, di cui sappiamo che determinerà in gran parte la natura della relazione con il figlio (Main, Kaplan, Cassidy, 1985), dato che la madre tenderà a identificarsi con questa immagine nel suo nuovo ruolo materno.

Dal momento in cui il terapeuta è investito transferalmente e riceve le identificazioni proiettive della madre, sperimenta una reazione emotiva accompagnata generalmente da pensieri associativi il cui insieme costituisce il contro-transfert o contro-atteggiamento. Sono soprattutto queste reazioni contro-transferali, prossime alla coscienza, a essere

immediatamente disponibili come materiale informativo per la comprensione dinamica della relazione. Non bisogna, tuttavia, sottovalutare il rischio di agiti ai quali queste identificazioni proiettive possono spesso indurre il terapeuta, attraverso la contro-identificazione con le caratteristiche dell'oggetto che è stato depositato in lui; la reazione che bisogna temere maggiormente, sul piano contro-transferale, è quella – frequente – di rifiuto e di abbandono, corrispondente alla stessa rappresentazione proiettata dalla madre, che porta all'interruzione intempestiva della terapia.

LE FONTI DI INFORMAZIONE

Come abbiamo segnalato poco sopra, a differenza di ciò che succede quando si adotta un punto di vista esclusivamente "behaviorista" durante l'osservazione della relazione madre-figlio, riteniamo che la situazione terapeutica abbia alcune caratteristiche che ci permettono di acquisire un numero importante di informazioni.

I discorsi del genitore, nel contesto della relazione emotiva con il terapeuta (pre-transfert) e della relazione con il figlio, così come le reazioni contro-transferali, possono permettere di inferire i fantasmi inconsci. A ciò si aggiungono i dati direttamente osservabili durante l'intervento, come la valutazione dell'organizzazione psichica del figlio e della madre.

È da questo insieme che emerge, per noi, la comprensione globale della configurazione psicodinamica della relazione madre-figlio, che ci permette la scelta di una conflittualità centrale (focus) e la formulazione dell'interpretazione.

L'INTERPRETAZIONE

In un contesto di pretransfert positivo predominante, le condizioni di ricettività sono ottimali e l'interpretazione diventa possibile. Come abbiamo segnalato, una parte della proiezione della madre sul figlio è "trasferita" sul terapeuta e l'interpretazione permette alla madre di riappropriarsi delle proprie proiezioni che peserebbero sul figlio, aprendo così la strada a una elaborazione intrapsichica del conflitto. Ciò permette altri modi di relazione e la rottura del meccanismo ripetitivo che provocava i sintomi.

Tecnicamente, in questi interventi brevi, non formuliamo interpretazioni transferali dirette che riguardino il terapeuta; interpretiamo, invece, il transfert che la madre compie sul figlio come ripetizione delle relazioni con i propri oggetti primitivi, con le ansie e i conflitti. Tra le proiezioni di immagini primitive che la madre effettua sul figlio, diamo priorità alle proiezioni anaclitiche non edipiche: la madre che protegge, rassicura e soddisfa, la cui ansia essenziale, legata a questa relazione, è la paura della separazione e della perdita. Abbiamo potuto constatare che queste immagini anaclitiche inglobano e comprendono le immagini edipiche e permettono un trattamento dei conflitti che genera molte meno resistenze. Per ragioni simili, evitiamo, per quanto è possibile, di interpretare il transfert negativo; prenderlo in considerazione condurrebbe necessariamente a instaurare un processo psicoterapeutico di lunga durata.

Pensiamo che, se non si stabiliscono nuovi legami preconsci connessi alle interpretazioni e senza le trasformazioni che essi operano, sia a livello delle proiezioni sul figlio che delle identificazioni materne, è molto elevato il rischio che i meccanismi di ripetizione si reinstallino. I miglioramenti osservati nei casi in cui non sono fornite interpretazioni possono essere compresi come "guarigioni transferali". La madre, scaricando i propri conflitti sul terapeuta, vive un sentimento di sollievo passeggero, il cui esito è tuttavia incerto.

Per noi, il terapeuta ha, in tutti i casi, il ruolo di contenitore delle proiezioni della madre ed eventualmente del figlio. In accordo con la teoria di Money-Kyrle (1956) e con i modelli di Rosenfeld (1965) e Bion (1965) segnalati precedentemente, il terapeuta modifica la parte del paziente che è stata depositata in lui, tramite identificazione proiettiva, grazie al proprio "insight" e all'attività mentale che l'accompagna. Nel momento in cui si produce una interpretazione, questa parte viene riproiettata in una forma modificata; la madre può allora reintroiettare non solamente l'oggetto interno o le altre parti di se stessa che aveva proiettato, ma anche un aspetto del terapeuta, ossia la parte dello psichismo del terapeuta capace di comprensione. La reintroiezione che accompagna l'interpretazione diventa allora una nuova risorsa interna, che aumenta la capacità d'introspezione e di comprensione di sé della madre e la aiuta a conferire nuovi significati ai propri contenuti psichici.

IV

"L'OMBRA DI SÉ" DEI GENITORI PROIETTATA SUL FIGLIO

PROIEZIONE, DA PARTE DEI GENITORI, DI ASPETTI INFANTILI DI SÉ, VISSUTI COME ABBANDONATI O "CARENZIATI"

Nella pratica della consultazione terapeutica genitori-figlio, la configurazione interrelazionale più diffusa è quella della proiezione, da parte del genitore, di un'immagine infantile di se stesso vissuta come "abbandonata" o "carenziata". Certo, questo caso si oppone al prototipo di proiezione parentale descritto da Freud, ossia la proiezione, da parte dei genitori, del proprio narcisismo sul figlio. Ma la condizione di genitorialità permette all'adulto di ripetere, nella relazione con il figlio, tutto un insieme di aspetti relazionali della propria infanzia con gli oggetti significativi del passato. Tramite questa ripresa, il genitore tenta di correggere, insieme e attraverso il figlio, i principali conflitti che ha incontrato con i propri genitori. Se i sentimenti di mancanza, di abbandono, di bisogno affettivo o di carenza del genitore sono troppo virulenti, possono essere compensati tramite una delega al figlio di aspetti infantili "abbandonati" o "carenziati".

Per "correggere il proprio passato", il genitore si appoggia all'identificazione complementare (proiettata sul figlio), con immagini genitoriali idealizzate, ossia dei "genitori che avrebbe voluto avere". Tramite queste identificazioni complementari, il figlio perde il proprio aspetto "abbandonato" agli occhi del genitore, che giungerà a vederlo come il bambino "idealmente coccolato" che avrebbe voluto essere egli stesso.

Ne consegue una modalità di relazione oggettuale di tipo narcisistico, in cui la relazione con il figlio serve a riparare il narcisismo ferito del genitore. Ovviamente, questo profitto narcisistico si può ottenere solamente alla condizione che questa configurazione relazionale "genitore ideale – figlio ideale" si mantenga in ugual misura. Questo equilibrio, molto spesso precario, viene messo alla prova da circostanze interattive diverse, che fanno ricomparire all'improvviso i timori che il narcisismo genitoriale

cerca di annullare. Non solo il genitore ritrova nel figlio l'immagine dell'abbandono tanto temuto, ma si vede identificato in immagini genitoriali che abbandonano, cosa che scuote ancor di più la sua autostima.

Se i fantasmi e il vissuto di mancanza dell'oggetto di soddisfacimento dei bisogni (oggetto anaclitico nel senso di Spitz) sono così preponderanti nello psichismo, ciò dipende essenzialmente dalla neotenia dell'essere umano. La scelta dell'oggetto di tipo anaclitico, così come è stato descritto da Freud, riguarda l'appoggiarsi della pulsione sessuale sull'oggetto di soddisfacimento dei bisogni vissuto come necessario per il soddisfacimento delle pulsioni di autoconservazione. Questo oggetto assicura la sopravvivenza, la sicurezza e il benessere. Nei casi estremi, la relazione con esso è sentita come indispensabile alla sopravvivenza, così che la frustrazione provoca reazioni aggressive pericolose o addirittura distruttive, commisurate al vissuto di minaccia interna e di sconforto, sperimentato dal soggetto.

Questa problematica, presente in ogni essere umano fin dall'infanzia, provoca una lotta difensiva accanita.

A causa della propria immaturità biologica e psichica, il neonato riattiva i vissuti anaclitici dei genitori e facilita la loro proiezione. Le circostanze in cui è stata vissuta dai genitori la mancanza determineranno i fantasmi interattivi che saranno privilegiati nella loro relazione con i figli, per esprimere e ripetere la propria problematica anaclitica.

Nella nostra casistica, abbiamo visto che la problematica anaclitica dei genitori si organizza schematicamente attorno a due forme cliniche differenti: 1) sentimenti di mancanza per *abbandono* da parte di oggetti significativi e 2) un vissuto di mancanza rappresentato come *carenza* di cure o di amore da parte di questi stessi oggetti. Il vissuto di abbandono e di carenza sono ubiquitari e facilmente riattivati in occasione di esperienze di perdita o di abbandono fantasmatiche o reali. Tali esperienze portano i genitori a costruire un'immagine genitoriale più o meno idealizzata, che permette loro di mettersi al riparo dai vissuti di mancanza o di frustrazione.

CHARLIE PIANGE LA TRISTEZZA DI SUA MADRE[1]

Proiezione di un'immagine infantile di sé vissuta come abbandonata e incapace di sopportare la perdita di una persona cara.

1. Tutti i dati personali degli esempi clinici citati in questo libro sono stati soppressi o mascherati al fine di preservare l'anonimato dei pazienti.

Charlie ha cinque anni quando la sua maestra invita la madre a chiedere una consultazione, qualche mese dopo l'inizio della scuola. Si è accorta che, da poco, Charlie si separa molto difficilmente dalla madre, piange molto e si fa consolare a lungo sulle sue ginocchia. All'inizio dell'anno, non presentava alcuna difficoltà di questo genere. Peraltro, quando lascia le ginocchia dell'insegnante, si dà a un'iperattività di tipo maniacale, sottolineata da queste parole: "Sono il più forte, sono il toro". Cerca poi costantemente di essere il centro d'interesse della classe e presenta cospicue difficoltà relazionali.

Alla consultazione si presentano il padre, la madre e Charlie.

Il bambino si sistema sulle ginocchia della madre, non vuole né giocare, né parlare. La madre dice che Charlie non aveva voglia di venire, e il bambino conferma, cercando in maniera tirannica di convincere i genitori a lasciare lo studio. I genitori si mostrano a disagio. La madre insiste con il figlio affinché spieghi le ragioni delle sue difficoltà scolastiche. Il terapeuta propone che tutti insieme cerchino di capire cosa succede. Alla domanda del terapeuta, la madre descrive i pianti, le crisi e la disperazione del figlio nel momento in cui deve lasciarlo, quando lo porta a scuola due volte al giorno.

Per rispondere alla domanda relativa al momento in cui sono apparse queste difficoltà, la madre associa un avvenimento familiare doloroso: ha recentemente perso la nonna materna, che adorava. È molto commossa e piange, ricordando questa "nonna che era un tesoro e che capiva tutto con un amore illimitato". Dall'inizio dei suoi anni di scuola e fino alla fine dell'adolescenza, si recava quotidianamente da lei, perché i suoi genitori avevano poco tempo da dedicarle. Aggiunge che Charlie era molto legato alla bisnonna e che è dalla sua morte che ha cominicato a piangere a scuola. Il terapeuta dice alla madre: "È senza dubbio doloroso per lei perdere questa nonna ed è come se suo figlio piangesse la sua tristezza". La madre, allora, ricorda la propria difficoltà a stare sola in casa quando i figli sono a scuola, poiché non può nascondersi il proprio dolore.

Fin da piccolo, Charlie, al contrario della sorella maggiore, si è mostrato facilmente oppositivo, rispondendo con crisi di rabbia alle frustrazioni. Il bambino, che brontolava fin dall'inizio del colloquio, si arrabbia allora in maniera impressionante, rimproverando alla madre di non dargli abbastanza cioccolato per la ricreazione. La madre cerca di calmarlo con delle promesse ma ciò produce l'effetto di farlo infuriare ancora di più e di fargli chiedere di tornare a casa immediatamente. I genitori non sono molto

lontani dal cedere alla sua richiesta. Il terapeuta, allora, interviene in maniera decisa e dice al bambino che non hanno ancora finito di parlare. La madre parla del proprio senso di colpa di fronte alle frustrazioni che impone al figlio. Il terapeuta cerca di dimostrarle che, attraverso questo tipo di relazione, mantiene un legame con questa nonna che le regalava tutto, rinunciando così a porre dei limiti al figlio. Charlie si calma all'improvviso ed esprime la propria paura che la madre muoia, quando la lascia, così come la paura di morire egli stesso.

Durante la seconda consultazione, i genitori sono più distesi e annunciano subito che il bambino si separa molto più facilmente dalla madre, benché si dimostri sempre insopportabile in classe. Charlie prende una sedia a fianco del padre, quella che la madre occupava la volta precedente, e la madre interpreta questo gesto come il desiderio di sedersi sulle sue ginocchia. Poi si mette a giocare. Prende della pasta da modellare, facendo finta di tirarla addosso al padre e al terapeuta, e afferma che si tratta di cacca che vuole lanciare negli occhi e nella bocca. La cacca diventa veleno destinato a ucciderli. I genitori sono a disagio e chiedono al figlio di calmarsi. Il terapeuta esplicita il suo desiderio edipico: "Se vuoi uccidere tuo padre o uccidere me, è perché ami talmente tua madre che desideri rimanere solo con lei". Questa interpretazione genera in Charlie un'immensa collera: grida, esige di ritornare a casa e se la prende con la madre che non gli ubbidisce, minacciandola di morte. Il terapeuta gli parla del suo dolore di sentirsi piccolo e così impotente, tanto da aver voglia di ucciderli, per non sentire la paura che muoiano "per davvero".

Charlie prende una matita e disegna le quattro persone presenti e vive. Il padre riferisce il proprio desiderio di giocare con il figlio, cosa che non è mai stata possibile prima.

All'incontro seguente, Charlie e i suoi genitori sono contenti.

Il bambino non presenta più difficoltà di separazione, gli piace la scuola e si è ben inserito. Gioca volentieri da solo o con gli altri e si mostra disposto a imparare. A casa è più docile nei conflitti che lo oppongono alla sorella e cerca il contatto con il padre. Di comune accordo, si pone fine alle consultazioni.

Alla fine dell'anno scolastico la maestra conferma la buona evoluzione del bambino, sia sul piano relazionale che su quello dell'apprendimento. Madre e figlio hanno potuto far fronte senza grande difficoltà a un nuovo lutto, di cui la madre ha parlato con l'insegnante.

Analisi del caso

Proiezione dei genitori. La madre proietta sul figlio la rappresentazione di se stessa abbandonata e incapace di sopportare la separazione dalla nonna deceduta.

Contro-identificazione dei genitori. La madre si identifica con la nonna, oggetto reale perso e idealizzato per far fronte al sentimento di mancanza rispetto ai propri genitori (spostamento). Di fatto, si mostra sottomessa al figlio e non può mantenere i limiti che ella stessa tenta di imporgli.

Scopo della proiezione. Tutto questo permette alla madre di evitare un lutto e manifestazioni di ostilità nei confronti dei propri genitori. Anche l'aggressività verso il figlio è rimossa.

Reazione del bambino alla proiezione genitoriale. Il figlio si identifica con l'oggetto proiettato.

Comprensione dei sintomi del bambino. Ricettacolo della proiezione, egli reagisce alla separazione tramite un atteggiamento megalomanico di controllo e di onnipotenza. Di conseguenza, non sopporta la frustrazione e si comporta in maniera simile in altre situazioni, compreso il conflitto edipico, in cui manifesta un'ostilità feroce nei confronti dell'oggetto rivale (identificazione maniacale con l'oggetto persecutore). Presenta un disturbo di carattere ipomaniaco.

Pretransfert dei genitori. Malgrado l'ambivalenza dell'inizio, il pretransfert dei genitori è positivo e non si è potuto rilevare un transfert che provocasse una resistenza. Facciamo l'ipotesi che essi abbiano potuto vedere, nella persona del terapeuta, il rappresentante della nonna di cui hanno parlato.

Pretransfert del bambino. Il bambino reagisce negativamente alla presenza del terapeuta. Vede in lui il terzo che lo minaccia di separarlo dalla madre. In un secondo momento, lo vede come un rivale edipico da attaccare in maniera grandiosa. È solo in un terzo momento e in assenza del terapeuta che il bambino, sollevato, può esprimere il pretransfert positivo edipico, particolarmente quando dice alla maestra che il terapeuta gli ha salvato la vita.

Contro-reazione del terapeuta. Il terapeuta reagisce in maniera complementare al pretransfert dei genitori, forse soprattutto a quello della madre.

Interventi e interpretazioni del terapeuta. Nei suoi interventi, il terapeuta adotta prima di tutto una posizione di autorità rispetto ai tentativi di Charlie di prendere il controllo. In seguito, interpreta alla madre la sua proiezione sul figlio del proprio vissuto d'abbandono, lasciando intendere il significato che questo acquista nell'elaborazione del lutto. La rivalità edipica viene poi interpretata al bambino insieme all'angoscia di separazione, insistendo sulle difese maniacali utilizzate per negare i sentimenti depressivi legati alla propria posizione infantile.

Questa situazione illustra il ruolo positivo che può giocare un terzo: in questo caso l'insegnante, che ha scoperto le manifestazioni sintomatiche del bambino, incoraggiato la richiesta di aiuto e accolto il transfert positivo laterale dopo il colloquio.

Dalla problematica anaclitica della madre derivano gravi difficoltà di separazione madre-figlio. La madre cerca costantemente di risparmiare al figlio i sentimenti depressivi che ella stessa proietta su di lui. Ciò nondimeno, la sua grande sollecitudine nei suoi confronti non è senza conseguenze nella conflittualità edipica del bambino. In effetti, questi vive l'attenzione che gli è rivolta come la realizzazione dei propri fantasmi di incesto e di parricidio. La sua megalomania ne risulta rinforzata; di fronte al terapeuta o a suo padre, Charlie si comporta come se si trovasse davanti a un rivale da eliminare. L'interpretazione alla madre della sua problematica anaclitica, rinforzata dal lutto con il quale si sta confrontando, non basta. Bisogna aggiungervi, così come ha fatto il terapeuta, un'interpretazione che vada a toccare la problematica edipica del bambino sia nel suo versante incestuoso che nella sua rivalità omicida. Il complesso di Edipo, con le sue caratteristiche maniacali, diventa allora evidente per la madre, e questo contribuisce ad attutirlo. Parallelamente ai cambiamenti che seguono rapidamente nella situazione familiare, Charlie può riprendere il proprio posto di figlio.

LA DOPPIA RAZIONE

Proiezione di un'immagine infantile di sé vissuta come carenziata (a livello orale).

Christine è una bambina di quattro anni, descritta come molto socievole. È stata adottata all'età di qualche settimana. Ha i tratti della madre naturale, di origine indiana. Tre mesi fa, la famiglia

ha adottato un bambino nord-americano. La madre adottiva chiede la consultazione perché la figlia si lamenta tutto il giorno di avere fame e reclama costantemente del cibo. Pesa 19 kg, con un'altezza di 107 cm. Le richieste diventano più insistenti quando la madre, che lavora part-time, è presente ed ella risponde con grande irritazione. Anche quando sono fuori casa, Christine le si avvicina e chiede da mangiare. La madre teme che diventi obesa, anche perché lei stessa era grassa in adolescenza e ne ha molto sofferto. Per la terapeuta, è subito chiaro che la madre si sente colpevole di non dedicare tutto il proprio tempo alla figlia e teme di frustrarla a ogni livello, cosa che le suggerisce durante il primo colloquio, al quale la madre si presenta da sola.

La madre piange e associa il proprio timore che alla figlia manchi sempre qualcosa. Ella cerca di rimediare ma aggiunge che, di questo passo, l'indipendenza di Christine non può essere sufficientemente incoraggiata. In più, quest'ultima non l'aiuta, poiché urla quando lei rifiuta di darle ciò che reclama.

La terapeuta si interroga sulla storia della donna e sulle ragioni che l'hanno spinta, con il marito, ad adottare dei bambini; le sarebbe stata "prognosticata" una sterilità, senza che ne abbia saputo di più. Sorprendentemente, sin dall'arrivo di Christine, la coppia ha chiesto di adottare un secondo figlio. La madre avrebbe avuto "un'infanzia felice" e, nel momento in cui la terapeuta le ricorda ciò che aveva detto del proprio corpo da adolescente e dei suoi sentimenti di essere stata messa in disparte, si mette di nuovo a piangere e si chiede se i suoi genitori avessero coscienza della sua sofferenza. Vive questa apparente indifferenza come una "mancanza d'affetto", tanto più che sua madre lavorava molto. Il padre sembra essere stato un "uomo di principi", con il quale comunicava poco. È la maggiore di tre figli molto vicini di età.

Christine ha "sempre saputo" di essere stata adottata, e chiede spesso che le si racconti la sua storia. La madre associa a proposito della frustrazione di non aver allattato la figlia, cosa che rimpiange ancora molto. Fin dall'età di due anni, Christine ha chiesto di giocare a fare la bambina piccola e ha reclamato il seno alla madre, che glielo dà fin da allora. La terapeuta stabilisce un legame fra il sintomo della bambina e il bisogno della madre di poterla nutrire per colmare le proprie mancanze e le mancanze della figlia. La paziente aggiunge che anche il marito pensa che il comportamento di Christine sia in relazione a una frustrazione, che